

monotropism-autism-prevalence-global_de

Autismus und Monotropismus: Wie verbreitet sind sie wirklich?

Ein zitiertes Forschungsdossier – es überprüft die regionalen Autismuszahlen und die Frage „wie viel Prozent der Menschen monoton sind“.

Information, kein medizinischer Rat. Diese Zahlen beschreiben, wie viele Menschen als autistisch erfasst werden oder bei einem Monotropismus-Fragebogen hohe Werte erzielen. Zählen hängt stark davon ab, wer sucht, wie und wo. Nichts hiervon ist diagnostisch.

Zusammenfassung

- **Autismus ist nicht überall 1 %.** Die sauberste globale Zahl ist die Schätzung der **Global Burden of Disease (GBD) 2021**, die inzwischen von der WHO übernommen wurde: Etwa **1 von 127 Menschen (~0,8 %)** war 2021 im Autismus-Spektrum [1][2]. Für *Kinder* kommen gepoolte Übersichtsarbeiten weiterhin auf die langjährige Größe von **~1 von 100** [3]. Die Vereinigten Staaten – das am intensivsten gescreente Land – berichten **1 von 31 (3,2 %)** unter 8-Jährigen (CDC, Daten 2022) [4].
- **Regionale Unterschiede sind überwiegend ein Messartefakt, keine Biologie.** Dieselbe GBD-Studie fand die autismusbezogene Krankheitslast in Südost-/Ostasien und Ozeanien am *niedrigsten* und in der Hochlohn-Superregion am *höchsten* [1]. Dieses Muster spiegelt diagnostische Infrastruktur, Bewusstsein und Screening wider – nicht echte Unterschiede in der Häufigkeit von Autismus.

- **Die oft zitierte regionale Tabelle ist für den Nahen Osten substantiell falsch und für Asien zu stark vereinfacht.** Eine Metaanalyse von 2025 legt die gepoolte Prävalenz für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) auf lediglich **~0,14 %** fest (Spanne 0,01 % Oman → 2,51 % Saudi-Arabien) [6], und eine asiatische Metaanalyse berichtet für Ostasien **~0,51 %** und für das chinesische Festland **~0,7 %** [5][7] – weit unter den oft für die arabische Welt behaupteten „0,9–1,5 %“.
- **Für Monotropismus gibt es keine vereinbarte „Prävalenz“, und die Angabe „15–20 % der Menschen sind monotron“ ist ein Kategorienfehler.** Monotropismus ist ein *dimensionaler* kognitiver Stil (ein kontinuierliches Merkmal), keine Diagnose. Die einzige große empirische Studie – der **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 – ergab für autistische Teilnehmende im Mittel **4,15/5** und für nicht-autistische **3,19/5**, bei deutlicher Überschneidung [10]. Sie sagt **nicht**: „X % der Menschen sind monotron.“
- **Die Behauptung „über 90 % der autistischen Menschen sind monotron“ ist eine theoretische Aussage darüber, wie gut die Theorie autistisches Erleben trifft, kein gemessener Prozentsatz.** Als *subjektive Validität* ist sie vertretbar, als *Epidemiologie* ist sie irreführend.

1. Wie viele Menschen sind autistisch? (und warum es zwei Schlagzahlen gibt)

Zwei Zahlen kursieren, und sie beantworten leicht unterschiedliche Fragen:

- **~1 von 100 Kindern.** Diese Zahl ergibt sich aus dem Pool dutzender Studien in systematischen Übersichtsarbeiten (z. B. Zeidan et al., 2022) und ist die langjährige, *kinderbezogene* Zusammenfassung der WHO [3]. Sie spiegelt Studien wider, die überwiegend pädiatrische Populationen screenen.
- **1 von 127 Menschen (~0,79 %), alle Altersgruppen.** Dies ist die modellierte Schätzung der **GBD 2021** – 61,8 Millionen Menschen im Jahr 2021 –, die die WHO inzwischen wörtlich übernommen hat („Im Jahr 2021 hatten etwa 1 von 127 Personen Autismus“) [1][2]. Pro Kopf

ist sie niedriger, weil sie die gesamte Lebensspanne umfasst, auch ältere Generationen, die nie gescreent wurden.

Die Lücke zwischen „1 von 100“ und „1 von 127“ ist kein Widerspruch: Die erste Zahl betrifft Kinder; die zweite alle. Beide sind vertretbar, wenn die Bezugsbevölkerung angegeben wird.

Die GBD liefert zudem eine klare Geschlechteraufschlüsselung – etwa **1,06 % der Männer** gegenüber **0,51 % der Frauen** (1.064,7 vs. 508,1 pro 100.000) –, was die gut belegte Untererkennung autistischer Mädchen und Frauen widerspiegelt, keinen zweifachen biologischen Unterschied [1].

2. Warum regionale Zahlen differieren (die Unterschiede messen überwiegend *Erkennung*, nicht *Biologie*)

Das ist der wichtigste Punkt beim Lesen jeder regionalen Tabelle. Die Autorinnen und Autoren der GBD 2021 fanden, dass die autismusbezogene Krankheitslast von **126,5 verlorenen Lebensjahren (DALYs) pro 100.000** in der Superregion Südostasien/Ostasien/Ozeanien bis zu **204,1 pro 100.000** in der Hochlohn-Superregion reichte [1]. Einfach gesagt: Die reicheren, stärker gescreenten Teile der Welt *finden* weit mehr Autismus als der Rest.

Die Treiber dieser Lücke sind fast ausschließlich methodischer und sozialer Natur:

- **Diagnostische Infrastruktur** – aktive Überwachungsnetzwerke (z. B. das ADDM der US-CDC) suchen systematisch in Schulen und Kliniken nach Fällen; viele Länder haben kein solches System und sind auf passive klinische Akten angewiesen.
- **Kriterien und Bewusstsein** – der Wechsel von der engen „autistischen Störung“ (DSM-IV) zum breiteren Autismus-Spektrum (DSM-5, 2013) sowie wachsendes öffentliches und fachliches Bewusstsein haben die *identifizierte* Prävalenz in Ländern, die erneut screenen, stetig steigen lassen.
- **Stigma, Sprache und Zugang zu Versorgung** – in vielen Regionen wird Autismus untergemeldet, weil Familien Stigma erfahren, Dienste

fehlen oder Screening-Instrumente in der lokalen Sprache und Kultur nicht validiert sind.

Wenn eine Tabelle also „0,1 % in Region X und 3 % in Region Y“ zeigt, lesen Sie das als „*Region Y sucht gründlicher und hat mehr Diagnosekapazität*“, nicht als „*Autismus ist in Region X dreißigmal seltener*“. Genau das betonen die GBD-Autoren: Eine bessere globale Datenabdeckung ist nötig, bevor geografische Variation zuverlässig gedeutet werden kann [1].

3. Eine korrigierte regionale Tabelle

Die Zahlen, die dieses Dossier ausgelöst haben, werden hier der besten verfügbaren Evidenz gegenübergestellt. Die Spalte „Beste Schätzung“ zitiert primäre systematische Übersichtsarbeiten oder das GBD-Modell – keine Advocacy-Auflistungen.

Region	Oft zitierte Zahl	Was die Evidenz stützt	Quelle
Welt – alle Altersgruppen	„1 %“	1 von 127 (~0,79 %) im Jahr 2021 (GBD; inzwischen WHO-Zahl)	[1][2]
Welt – Kinder	„1 von 100“	~1 von 100 Kindern (gepoolte Übersichtsarbeiten)	[3]
Nordamerika	„1–3,2 %“	3,2 % (1 von 31) US-amerikanische 8-Jährige (2022, CDC ADDM); ~1 von 45 Erwachsenen	[4]
Europa	„0,7–1 %“	Registerbasierte Studien gruppieren sich um ~1 % (z. B. Dänemark, Finnland, Island); bevölkerungsbezogene Schätzungen etwas höher	[3]
Naher Osten und Nordafrika	„0,9–1,5 %“	Gepoolt ~ 0,14 % (95 %-KI 0,02–0,36 %); Länderspanne 0,01 % (Oman) → 2,51 % (Saudi-Arabien)	[6]
Ost-/Südostasien	„0,4–1,4 %“	Asiatische Metaanalyse: Ostasien ~ 0,51 % , Südasien ~0,31 %, Westasien ~0,35 %; chinesisches Festland ~ 0,7 % (1 von 143) ; stark gescreente Inseln (Singapur, Japan, Südkorea) berichten höhere Werte	[5][7]

Zwei Erkenntnisse aus der Tabelle:

1. Die **nordamerikanischen** und **europäischen** Spannen sind im Großen und Ganzen richtig – dies sind die am stärksten gescreenten Regionen, daher sind ihre hohen Zahlen zu erwarten.
2. Die **MENA-Zahl** ist der große Fehler. Eine gepoolte Prävalenz nahe **0,14 %** spiegelt mit hoher Wahrscheinlichkeit *Unterdiagnose und schwache Überwachung* wider, nicht einen tatsächlich selteneren Autismus. Die enorme Streuung innerhalb der Region (Oman 0,01 % bis Saudi-Arabien 2,51 %) ist selbst das Indiz: Echte Biologie variiert zwischen Nachbarländern nicht so stark; Überwachung schon [6].

4. Nimmt Autismus tatsächlich „zu“?

Die Schlagzahl der Prävalenz ist stark gestiegen – in den USA von rund 1 von 150 (2000) auf 1 von 31 (2022) [4]. Die vorherrschende Erklärung der Epidemiologinnen und Epidemiologen lautet **bessere und breitere Erfassung**, nicht zwingend mehr Autismus:

- erweiterte Kriterien (DSM-IV → DSM-5),
- aktive Fallfindung (ADDM-artige Überwachung),
- früheres und gerechteres Screening über Geschlecht, Ethnizität und Herkunft hinweg,
- verringertes Stigma, das zu mehr Diagnostik führt.

Die GBD-Autoren merken an, dass die Prävalenz dort, wo die Datenqualität kontrolliert wird, vergleichsweise *stabil* ist und dass scheinbare „Zunahmen“ weitgehend die Erkennungskapazität abbilden [1]. Das ehrliche Fazit: **Wir zählen zunehmend Autismus, der schon immer da war.**

5. Wie viele Menschen sind „monotron“? (die Frage ohne eindeutige Antwort)

Monotropismus (Murray, Lawson & Lesser, 2005) ist eine *aufmerksamkeitsbasierte* Erklärung von Autismus: Ein monotroper Geist konzentriert seine Ressourcen auf wenige, intensiv erregte „Aufmerksamkeitstunnel“, anstatt Aufmerksamkeit über viele Kanäle zu

verteilen (Polytropismus). Entscheidend ist, dass er als **Unterschied in der Aufmerksamkeitsverteilung, nicht als Defizit** und als **Spektrum**, nicht als Ja/Nein-Kategorie verstanden wird.

Daher gibt es **keine vereinbarte Prävalenz des „Monotropismus“**, aus drei strukturellen Gründen:

1. **Er ist keine Diagnose.** Monotropismus kommt weder im DSM-5 noch in der ICD-11 vor. Es gibt kein Fallregister und keine Diagnoseschwelle.
2. **Er ist dimensional, nicht kategorial.** Jeder kann in einen fokussierten „Flow“-Zustand geraten; der autistische Unterschied besteht darin, dass tiefer, enger Fokus der *Standard-Modus* ist und nicht nur ein gelegentlicher Zustand. Eine Grenze zwischen „monotron“ und „polytrop“ wäre willkürlich.
3. **Das Instrument liefert Mittelwerte, keine Fälle.** Das validierte Instrument – der **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 – ergibt eine kontinuierliche Punktzahl von 1 bis 5, und die Forschenden vergleichen *Gruppenmittelwerte*, nicht „wie viele Menschen einen Schwellenwert überschreiten“ [10].

Die tatsächlichen Zahlen, die wir haben (MQ-Validierungsstudie)

In der Entwicklungsstudie des MQ (1.110 Teilnehmende: 756 autistisch, 354 nicht-autistisch) [10]:

- **Autistische Teilnehmende: Mittelwert 4,15 / 5 (SD 0,347)**
- **Nicht-autistische Teilnehmende: Mittelwert 3,19 / 5 (SD 0,578)**
- **ADHD-Status** sagte unabhängig höhere Monotropismus-Werte voraus (relevant, weil Autismus und ADHD je nach Richtung in rund 30–80 % der Fälle gemeinsam auftreten).
- Eine explorative Faktorenanalyse ergab eine **8-Faktoren-Struktur** (Spezialinteressen; Grübeln/Angst; Bedürfnis nach Routinen; Umwelt & der Aufmerksamkeitstunnel; den Kontakt zur Umgebung verlieren; Entscheidungsfindung; angstmindernde Wirkung von Interessen; den Umgang mit sozialen Interaktionen).

Die Überschneidung der beiden Verteilungen ist beträchtlich – viele nicht-autistische Menschen erzielen höhere Werte als einige autistische Menschen und umgekehrt. Diese Überschneidung ist *genau* der Grund,

warum eine Schlagzeile „X % der Bevölkerung sind monotron“ ohne einen willkürlichen (und umstrittenen) Schwellenwert nicht aussagekräftig ist.

6. Woher die Zahlen „über 90 %“ und „15–20 %“ kommen – und warum es keine Prävalenzdaten sind

Diese beiden Zahlen, die online weit verbreitet sind, verdienen eine direkte Faktenprüfung.

„**Über 90 % der autistischen Menschen sind monotron.**“ Dies liest sich am besten als eine Aussage über **subjektive Validität** – also: *wenn autistische Menschen auf die Monotropismus-Rahmung treffen, erkennt eine überwältigende Mehrheit sie als zutreffende Beschreibung ihres Erlebens an*. Das ist ein reales und bedeutsames Phänomen (der MQ wurde mit einer autistisch geführten Community-Gruppe entwickelt, gerade weil die Beschreibung nachhallt [10]). Aber es ist **keine epidemiologische Prävalenz**; keine Studie hat „den Anteil autistischer Menschen, die monotron sind“ gegen eine validierte Schwelle berechnet, weil es keine vereinbarte Schwelle gibt. Formuliert als „*Monotropismus hat für autistische Menschen eine sehr hohe subjektive Validität*“, ist die Aussage vertretbar; als „über 90 % der autistischen Menschen sind monotron“ überzieht sie das Messbare.

„**15–20 % der Allgemeinbevölkerung sind monotron.**“ Diese Zahl ist fast sicher eine *Vermengung mit „Neurodivergenz“. Community-Schätzungen legen *irgendeine* Form von Neurodivergenz (ADHD, Legasthenie, Dyspraxie, Tourette u. a., mit starker Überschneidung) in der Größenordnung von 15–20 % der Bevölkerung. Zum Vergleich: Selbst die besser gemessenen Einzelbestandteile sind für sich genommen viel kleiner: Adulte ADHD betrifft etwa **2,58 %** (persistierend) bis **6,76 %** (symptomatisch) der Erwachsenen weltweit [8], und kindliche ADHD wird häufig auf rund 5–8 % geschätzt. Legasthenie wird je nach Definition oft bei ~10 % angesetzt. **Keine dieser Zahlen ist ein Monotropismus-Wert.** „Neurodivergent“ mit „monotron“ gleichzusetzen, ist ein Kategorienfehler: Monotropismus ist eine *Dimension* des kognitiven Stils, die bei mehreren neurodivergenten Profilen erhöht – aber nicht mit ihnen identisch – ist. Es gibt derzeit **keine evidenzbasierte Zahl** für die Prävalenz von Monotropismus in der Allgemeinbevölkerung.

Fazit zum Monotropismus: *Behandeln Sie ihn als eine messbare Neigung auf einem Spektrum, stark (aber nicht ausschließlich) mit Autismus und ADHD verknüpft, mit hoher Validität aus gelebter Erfahrung für autistische Menschen. Die ehrliche Antwort auf „wie viel Prozent der Menschen sind monotron?“ lautet: das ist noch keine wohldefinierte Frage, und jeder präzise Prozentsatz, den Sie sehen, ist erfunden.*

7. Praktische Erkenntnisse

- **Zitieren Sie die Zahl, die zur Bevölkerung passt.** „1 von 127 Menschen“ (alle Altersgruppen, GBD/WHO) und „~1 von 100 Kindern“ sind beide in Ordnung – benennen Sie, welche Sie meinen [1][2][3].
- **Behandeln Sie regionale Lücken als Erkennungslücken.** Niedrig gemeldete Prävalenz in MENA, Teilen Asiens sowie bei Mädchen/Frauen, älteren Erwachsenen und rassialisierten Gruppen spiegelt Untererkennung wider, nicht das Fehlen von Autismus [1][6].
- **Stellen Sie Monotropismus nicht so dar, als habe er eine Prävalenz.** Geben Sie MQ-Mittelwerte und das dimensionale Framing an; vermeiden Sie „über 90 %“ und „15–20 %“ als Prävalenzaussagen [10].
- **Behalten Sie das neuroaffirmierende Framing bei.** Höhere Autismus-erkennung in gut ausgestatteten Ländern ist ein Erfolg von Bewusstsein und Zugang; monotron vs. polytrop ist ein *Unterschied in der Aufmerksamkeit*, kein Defizit – im Einklang damit, wie die Urheberinnen und Urheber und die autistische Community die Theorie fassen.

Quellen

[1] Global Burden of Disease Study 2021 Autism Spectrum Collaborators (2024). *The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the Global Burden of Disease Study 2021*. The Lancet Psychiatry (19. Dez. 2024). doi:10.1016/S2215-0366(24)00363-8 — 61,8 Mio. Menschen (1 von 127) im Jahr 2021; altersstandardisierte Prävalenz 788,3/100.000 (Männer 1.064,7; Frauen 508,1); Superregion-DALYs 126,5 (SO-/O-Asien & Ozeanien) bis 204,1 (Hochlohn) pro 100.000.

[https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(24\)00363-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(24)00363-8/fulltext) · IHME-Zusammenfassung:

<https://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-epidemiology-and-health-burden-autism-spectrum-findings-global>

[2] World Health Organization (2024). *Autism fact sheet (key facts)*. — „In 2021 about 1 in 127 persons had autism.“ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

[3] Zeidan, J. et al. (2022). *Global prevalence of autism: A systematic review update*. Autism Research (Wiley). doi:10.1002/aur.2696 — ~1 von 100 Kindern; europäische Registerdaten (Frankreich, Dänemark, Finnland, Island).

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696>

[4] CDC, Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network (2025). *Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022*. MMWR, 74(SS-2). — 1 von 31 (3,2 %) unter 8-Jährigen.

Community-Bericht:

<https://www.cdc.gov/autism/media/pdfs/2025/04/ADDM-Community-Report-SY2022.pdf> · MMWR:

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm>

[5] Lu, Y. et al. (2020). *Prevalence of autism spectrum disorder in Asia: a systematic review and meta-analysis*. Psychiatry Research, 284, 112679. doi:10.1016/j.psychres.2019.112679 (PMID 31735373) — Ostasien 0,51 %, Südasien 0,31 %, Westasien 0,35 %.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735373>

[6] Abdallah, B.M. et al. (2025). *Estimates of the prevalence of autism spectrum disorder in the Middle East and North Africa region: a systematic review and meta-analysis*. BMC Public Health, 25:2519. doi:10.1186/s12889-025-23651-x (PMID 40691829) — gepoolt 0,14 % (95 %-KI 0,02–0,36 %); Länderspanne 0,01 % (Oman) bis 2,51 % (Saudi-Arabien).

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40691829>

[7] Jiang, X. et al. (2024). *Prevalence of autism spectrum disorder in mainland China over the past 6 years: a systematic review and meta-analysis*. BMC Psychiatry (PMID 38811881) — ~0,7 % seit 2017 (~1 von 143). Bestätigt durch einen Policy-Scoping-Review (SAGE) von 2024.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38811881>

- [8] Song, P. et al. (2021). *The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a global systematic review and meta-analysis*. General Psychiatry / PMC7916320 — persistierende adulte ADHD 2,58 %; symptomatische adulte ADHD 6,76 %.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7916320>
- [9] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.
doi:10.1177/1362361305051398 — Ursprung der Monotropismustheorie.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [10] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (47-Item-Selbstbeurteilungsinstrument; Validierungs-Preprint). Open Science Framework. — n = 1.110 (756 autistisch, 354 nicht-autistisch); autistischer Mittelwert 4,15 (SD 0,347) vs. nicht-autistisch 3,19 (SD 0,578) auf einer 1–5-Skala; ADHD sagte unabhängig höhere Werte voraus; 8-Faktoren-Struktur. Fragebogen-Datei: <https://osf.io/wpx5g> · Validierungs-Preprint: <https://osf.io/ft73y> · Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0. Lokales Archiv: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)